Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Respiratório

Asma na Criança

Do controle à crise

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Asma na criança e no adolescente · do controle à crise

I — É asma? — 3
Definição, história e o que mais chia

II — Como confirmar o diagnóstico? — 4
Os três critérios até 5 anos e a espirometria a partir de 6

III — A asma está controlada? — 5
Controle, gravidade da doença e risco futuro

IV — Como tratar a criança até 5 anos? — 6
Etapas, corticoide inalatório e espaçador

V — E o escolar e o adolescente? — 7
Etapas de 6 a 11 anos, CI-formoterol, doses de CI

VI — A crise é leve, moderada ou grave? — 9
Sinais, saturação, PFE e PRAM

VII — Como tratar a crise no pronto-socorro? — 10
Oxigênio, salbutamol, ipratrópio, corticoide

VIII — Não respondeu: internar, UTI ou intubar? — 12
Magnésio, critérios e o que não fazer

IX — Quando dar alta e como evitar a próxima? — 13
Alta, prescrição, retorno e plano de ação

X — Mapa de decisão e pegadinhas — 14

XI — Questões de estudo — 15

— Gabarito, fontes e anotações — 16

Como ler este caderno

Cai na prova — O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta — O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção — Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

As chaves entre colchetes indicam a fonte de cada dado: [MS] PCDT de Asma do Ministério da Saúde (2026), [ASBAI] guia ASBAI/SBP de exacerbação (2021), [GINA] GINA 2026, [SBP-NT] nota técnica SBP (2023). Lista completa no fim.

Capítulo I

É asma?

*Asma é doença heterogênea, com inflamação crônica das vias aéreas e sintomas que **variam** no tempo e na intensidade (sibilância, falta de ar, aperto no peito, tosse), com limitação variável do fluxo expiratório [MS] [SBP-NT].*

O que a história mostra

- Sintomas que vão e voltam, pioram à noite ou ao acordar, com exercício, riso, choro, alérgenos, frio e infecções virais [MS].
- Atopia pessoal ou familiar apoia, mas sua ausência não exclui [MS].
- Na criança pequena, entre os episódios, tosse seca ou falta de ar que piora no sono ou depois de rir, chorar ou brincar [MS].

Tabela 1 · *Quando o chiado aponta para outra coisa*

Pista	Pensar em
Início súbito, engasgo, sibilo unilateral	Corpo estranho
Tosse ao mamar, engasgos, infecções de repetição	Aspiração, refluxo
Sintomas desde o nascimento, prematuridade	Malformação, displasia broncopulmonar
Tosse úmida persistente	Bronquite bacteriana prolongada, bronquiectasia, tuberculose
Baixo ganho de peso, fezes alteradas, secreção abundante	Fibrose cística
Estridor, tosse metálica, ruído ao chorar	Malácia de via aérea, anel vascular
Sopro, baixo crescimento	Cardiopatia
Infecções graves em outros sistemas	Imunodeficiência

[GINA] [ASBAI]. Sinal focal, baqueteamento, sintoma contínuo, início muito precoce, déficit de crescimento ou falta de resposta com boa técnica pedem investigação [GINA].

Cai na prova · nem todo chiado é asma

No lactente, o chiado da bronquiolite é obstrução por muco e edema, não broncoespasmo. A asma se diagnostica pela **recorrência**, pela exclusão de outra causa e pela resposta ao tratamento (capítulo II) [MS].

Atenção · AIDPI: sibilância primeiro

Na criança com tosse ou dificuldade para respirar e sibilância, o AIDPI manda tratar e reavaliar a sibilância antes de classificar pneumonia, salvo quadro grave: taquipneia de broncoespasmo não é pneumonia [AIDPI].

Capítulo II

Como confirmar o diagnóstico?

Até 5 anos: três critérios juntos

Tabela 2 · *Diagnóstico de asma na criança ≤ 5 anos (PCDT)*

1. Recorrência	≥ 2 episódios agudos de sibilância nos últimos 12 meses, ou ≥ 1 episódio + sintomas intermitentes em outro momento. Cada episódio dura > 24 h, e a sibilância é confirmada ao menos uma vez
2. Exclusão	Sintomas improváveis de serem explicados por outro diagnóstico (história e exame completos)
3. Resposta	Melhora em **20–60 min** após SABA; na crise moderada ou grave com corticoide oral, em **3–4 h**. Ou resposta a teste terapêutico de **2–3 meses**

*[MS]. Critério incompleto: registrar **suspeita de asma**, tratar se indicado e reavaliar.*

Teste terapêutico com CI diário: indicado se houve ≥ 1 crise com atendimento de urgência, corticoide oral ou internação no último ano, ou sintomas mais de 2 vezes por semana. Beclometasona **100 mcg de 12/12 h**, reduzida para **50 mcg de 12/12 h** quando a resposta confirma o diagnóstico. Sintomas que voltam ao parar reforçam o diagnóstico [MS].

A partir de 6 anos: provar a variabilidade

- **Espirometria** a partir dos 6 anos (às vezes antes); em geral é **normal** mesmo com doença ativa: normal não exclui [MS].
- Resposta ao broncodilatador: aumento do **VEF1 ≥ 12%** após 200–400 mcg de salbutamol, medido em 10–15 min; suspender o SABA ≥ 4 h antes, se tolerado [MS].
- PFE: variabilidade diária média > **13%** em 2 medidas por dia por 2 semanas, sempre no mesmo aparelho [MS].
- Broncoprovocação acima de 5 anos com sintomas compatíveis e espirometria normal [MS].

Atenção · 12% de quê?

O PCDT escreve VEF1 ≥ 12% **do basal** na criança; o GINA, ≥ 12% **do previsto**. Não são equivalentes: use a redação da fonte da questão [MS] [GINA].

Exames que não são rotina

Radiografia: raramente; só se há dúvida (corpo estranho, malformação, tuberculose) ou complicação [MS] [ASBAI]. **Prick test ou IgE específica**: mostram sensibilização; negativos não excluem asma [MS]. **Hemograma**: afasta anemia e mostra eosinofilia [MS]. Espirometria não deve ser feita na suspeita de tuberculose [MS].

Capítulo III

A asma está controlada?

*Três coisas diferentes: o **controle** nas últimas semanas, a **gravidade da doença** (pelo tratamento que ela exige) e a **gravidade da crise** (capítulo VI) [MS].*

Tabela 3 · *Controle dos sintomas nas últimas 4 semanas*

≥ 6 anos	≤ 5 anos (PCDT)
Sintomas diurnos > 2×/semana	Sintomas diurnos por mais de alguns minutos, > 1×/semana
Despertar noturno por asma	Despertar ou tosse noturna
SABA para sintomas > 2×/semana	SABA > 1×/semana
Limitação de atividades	Limitação de atividades
Nenhum item: controlada · 1–2: parcialmente controlada · 3–4: não controlada	

[MS]. O GINA atual usa > 2×/semana também para ≤ 5 anos [GINA]. ACT (≥ 12 anos): controlada ≥ 20; c-ACT (4–11 anos): controlada > 19 [MS].

Gravidade da doença

- **Leve**: controlada com tratamento de baixa intensidade com CI.
- **Moderada**: precisa das etapas 3 ou 4 (CI-LABA em dose baixa ou média).
- **Grave**: não controlada apesar de CI-LABA em dose alta otimizado, ou precisa dele para ficar controlada — depois de corrigir técnica, adesão, exposição e comorbidades [MS].

Risco futuro: avaliar mesmo com sintomas controlados

≥ 1 exacerbação no último ano, tratamento só com SABA, uso excessivo de SABA (mais de 3 frascos de 200 doses por ano), má adesão ou técnica errada com o CI, VEF1 reduzido, tabagismo, eosinofilia e vulnerabilidade social [MS].

Cai na prova · controlada não quer dizer leve

A criança que só está controlada com CI-LABA em dose média tem asma **moderada**, por mais que esteja sem sintomas. A gravidade se mede pelo tratamento necessário, depois de 2–3 meses de tratamento [MS].

Conduta · antes de subir uma etapa

- Confirmar que os sintomas são de asma.
- Ver a técnica inalatória na frente do paciente e checar a adesão.
- Rever exposições (fumaça, mofo, alérgenos) e comorbidades (rinite, refluxo) [MS].

Capítulo IV

Como tratar a criança até 5 anos?

*Toda criança com asma ou suspeita de asma recebe **SABA inalatório** para alívio. Controlador diário com **CI** se sintomas mais de 2 vezes por semana ou ≥ 1 exacerbação grave com atendimento não programado no último ano [MS].*

Tabela 4 · *Etapas até 5 anos*

Etapa	Tratamento
1	Sibilância viral infrequente, pouco ou nenhum sintoma entre os episódios: SABA sob demanda; considerar CI intermitente no início da virose
2	**CI diário em dose baixa** por pelo menos 2–3 meses (ou CI intermitente com os sintomas). Sibilância viral frequente com sintomas entre as crises: fazer antes o teste com CI diário
3	**Dobrar** a dose baixa de CI; considerar especialista
4	Manter e **encaminhar**; CI-LABA só com especialista (evidência a partir de 4 anos)

[MS]. Em todas as etapas, alívio com SABA sob demanda. Dose baixa: beclometasona (pMDI, partícula padrão) 100 mcg/dia [MS]; budesonida nebulizada 500 mcg/dia [GINA].

Técnica: pMDI com espaçador

- Dispositivo de pó não serve para a maioria das crianças ≤ 5 anos: **pMDI com espaçador** [MS].
- Agitar, **1 jato por vez**, 5–6 respirações no espaçador após cada jato [GINA].
- Máscara vedando nariz e boca; passar ao **bocal** assim que a criança conseguir [MS] [GINA].



pMDI com espaçador e bocal. *O jato vai para a câmara, e a criança respira por ela; sem espaçador, quase nada chega ao pulmão.*

Conduta · plano em casa (até 5 anos)

Sinais de crise: mais tosse (sobretudo noturna), letargia, comer pior, SABA que não resolve. Começar SABA e reavaliar em até 1 h. Procurar atendimento se prostrada, sem resposta ou piorando (sobretudo < 1 ano), se precisar de ≥ 4 jatos em 4 h ou de SABA mais de 3 vezes nas primeiras 12 h. **Corticoide oral não é iniciado pelos pais** em casa [MS].

Atenção · MART não é para o pré-escolar

Não há estudos de manutenção e alívio com CI-formoterol abaixo de 5 anos [GINA]; a nota da SBP fala em uso a partir de 6 anos [SBP-NT].

Capítulo V

E o escolar e o adolescente?

6 a 11 anos (PCDT)

Tabela 5 · *Etapa inicial pelo quadro de 6 a 11 anos*

Quadro	Tratamento
Sintomas ≤ 1–2 dias/semana	**Etapa 1**: CI em dose baixa **sempre que usar o SABA** (inaladores juntos ou separados)
Sintomas 2–5 dias/semana	**Etapa 2**: CI diário em dose baixa + SABA sob demanda (ou CI sempre que usar SABA)
Sintomas na maioria dos dias ou despertar ≥ 1×/semana	**Etapa 3**: CI-LABA em dose baixa ou CI em dose média + SABA
Sintomas diários, despertares, função reduzida	**Etapa 4**: CI-LABA em dose média + SABA
Sem controle na etapa 4	**Etapa 5**: especialista, fenotipagem, terapia adicional

[MS]. O GINA 2026 acrescenta, de 6 a 11 anos, CI-formoterol só sob demanda na etapa 1 e manutenção e alívio (MART) nas etapas 3–4 [GINA]. A SBP apoia CI-formoterol (MART) a partir de 6 anos [SBP-NT].

Doses de corticoide inalatório (dose diária total)

Tabela 6 · *Dose baixa, média e alta*

Fármaco (partícula padrão)	Baixa	Média	Alta
6 a 11 anos (mcg/dia)			
Beclometasona pMDI	100–200	> 200–400	> 400
Budesonida (DPI ou pMDI)	100–200	> 200–400	> 400
≥ 12 anos (mcg/dia)			
Beclometasona pMDI	200–500	> 500–1.000	> 1.000
Budesonida (DPI ou pMDI)	200–400	> 400–800	> 800

[MS]. Faixas de dose, não tabela de equivalência; a dose baixa basta para a maioria.

Cai na prova · qual combinação serve de alívio

Só CI com **formoterol**, que age rápido. CI-salmeterol (início lento) e CI-vilanterol ou indacaterol (sem segurança com várias doses ao dia) **não** servem de alívio; e CI-formoterol de alívio não se soma a manutenção com outro LABA [MS].

12 anos ou mais: dois regimes

Tabela 7 · *Regime preferencial: budesonida-formoterol 200/6 mcg (dose medida)*

Etapa	Uso
1 e 2	**1 inalação sob demanda**, sem manutenção (alívio anti-inflamatório, AIR)
3	1 inalação 1 ou 2 vezes ao dia + 1 sob demanda (MART)
4 e 5	2 inalações 2 vezes ao dia + 1 sob demanda

Máximo: 12 inalações por dia *(72 mcg de formoterol), somando manutenção e alívio; precisar de mais em 24 h: procurar atendimento [GINA]*

[MS]. 200/6 mcg medida = 160/4,5 mcg liberada. De 6 a 11 anos usa-se a apresentação 100/6 mcg [MS].

Regime alternativo (quando o preferencial não é viável, ou paciente estável, aderente e sem exacerbações no último ano): etapa 1, CI sempre que usar SABA; etapa 2, CI diário em dose baixa + SABA; etapa 3, CI-LABA em dose baixa ou CI em dose média; etapa 4, CI-LABA em dose média [MS].

Reduzir e acompanhar

- Reduzir só após pelo menos **3 meses** estável; em adolescentes, cortes de 25–50% a cada 3 meses. Não suspender o CI por completo [MS].
- Espirometria no início, em 3–6 meses e, em uso contínuo, a cada 6 meses [MS].
- Prevenção: adesão ao CI, técnica revista a cada consulta, eliminar fumaça de cigarro e vape, mofo e alérgenos relevantes, atividade física, vacinação em dia [MS].

Atenção · asma grave (etapa 5)

Encaminhar ao especialista para fenotipagem. Imunobiológicos do PCDT para criança: mepolizumabe 40 mg SC a cada 4 semanas (6–11 anos) ou 100 mg (≥ 12 anos); omalizumabe pela IgE e pelo peso; dupilumabe. Tiotrópio não está incorporado no SUS para asma [MS].

Cai na prova · SABA sozinho não é tratamento

O uso exclusivo de SABA não é recomendado: o excesso de SABA aumenta o risco de crise e até de morte por asma. Na alta de uma crise, sempre sair com **tratamento que contenha CI** [MS].

Capítulo VI

A crise é leve, moderada ou grave?

Avaliar enquanto já trata. A criança, e sobretudo o lactente, fica hipoxêmica mais rápido que o adulto [ASBAI].

Tabela 8 · *Gravidade da crise*

	Leve	Moderada	Grave
Fala e postura	Falta de ar ao andar, deita, fala frases	Falta de ar em repouso, prefere sentar, fala frases curtas, agitada	Sentada ereta, fala palavras; sonolenta ou confusa nos muito graves
Esforço	Sem musculatura acessória	Musculatura acessória	Acessória acentuada
Sibilos	Esparsos, fim da expiração	Difusos, expiratórios	Inspiratórios e expiratórios; **tórax silencioso** nos muito graves
PFE (% previsto)	≥ 70%	40–69%	< 40%
SatO2 em ar	> 95%	90–95% (< 5 a: 92–95%)	< 90% (< 5 a: < 92%); cianose

[ASBAI]. Bradicardia nos casos muito graves. Hipercapnia surge mais rápido na criança pequena.

Saturação

Na criança, SatO2 < **92%** prediz internação, e < **90%** pede tratamento mais agressivo [ASBAI] [MS]. No início do salbutamol a saturação pode cair 5% ou mais nos primeiros 30 min (desequilíbrio ventilação-perfusão) [ASBAI].

PFE (escolar)

< 50% do previsto: atendimento imediato; < 35%: risco de vida [ASBAI].

PRAM (2 a 17 anos)

Retração supraesternal	0 / 2
Contração de escalenos	0 / 2
Entrada de ar: normal 0 · reduzida nas bases 1 · redução difusa 2 · mínima ou ausente 3	0 a 3
Sibilos: ausentes 0 · só expiratórios 1 · inspiratórios (± expiratórios) 2 · audíveis sem estetoscópio ou tórax silencioso 3	0 a 3
SatO2 ≥ 95 / 92–94 / < 92%	0 / 1 / 2

Leve 0–3 · moderada 4–7 · grave 8–12 [ASBAI] [GINA].

Atenção · pouco sibilo pode ser o pior

Sibilo audível costuma ser crise moderada; a ausência de sibilo com pouca entrada de ar (**tórax silencioso**), sonolência, cianose ou esforço que diminui sem melhora são sinais de ameaça à vida [ASBAI] [GINA]. Procurar também pneumotórax, pneumonia, corpo estranho e anafilaxia; se houver **anafilaxia**, adrenalina IM **primeiro**, depois o broncodilatador [MS] [GINA].

Capítulo VII

Como tratar a crise no pronto-socorro?

Tratar já, enquanto se faz uma anamnese breve. Os três pilares: ***oxigênio*** *se hipoxêmico,* ***broncodilatador*** *repetido e* ***corticoide sistêmico*** *precoce [MS] [ASBAI].*

Tabela 9 · *Primeira hora*

Medida	Dose e modo
Oxigênio	Cateter ou máscara (1–3 L/min costuma bastar), titulado para **SatO2 ≥ 94%** [ASBAI]. O GINA inicia se < 92% e mira 92–95% no escolar e ≥ 92% no pré-escolar [GINA]
Salbutamol	pMDI 100 mcg com espaçador, **1 jato por vez**: 4–10 jatos a cada 20 min na 1ª hora [MS]. Por peso: 5–10 kg 4 jatos · 10–20 kg 6 jatos · > 20 kg 8 jatos [ASBAI]. Pré-escolar com crise moderada ou grave: 4–6 jatos, até 3 vezes, a cada 20–30 min [GINA]. Nebulização se não coopera ou crise muito grave; no ≤ 5 anos, 2,5 mg por dose [GINA] [ASBAI]
Ipratrópio	Só junto com o SABA, na crise moderada ou grave: nebulização 125–250 mcg (< 4 anos) ou 250–500 mcg (≥ 4 anos), até 3 vezes a cada 20 min na 1ª hora [ASBAI]; ou 4 jatos de 20 mcg [GINA]. Sem benefício depois de 1–2 h [GINA]
Corticoide	Na 1ª hora, em toda crise moderada ou grave; **via oral**, tão eficaz quanto a venosa. Venosa (hidrocortisona, metilprednisolona) se vomita, não engole ou vai para VNI ou intubação. Leva cerca de 4 h para agir [ASBAI]

Tabela 10 · *Corticoide oral na crise (prednisolona ou prednisona)*

Idade	Dose	Duração
< 2 anos	1–2 mg/kg/dia, máx. **20 mg/dia**	3–5 dias
2–5 anos	1–2 mg/kg/dia, máx. **30 mg/dia**	3–5 dias
6–11 anos	1–2 mg/kg/dia, máx. **40 mg/dia**	3–5 dias
Adolescente	40–50 mg/dia	5–7 dias
Alternativa	Dexametasona VO 0,3–0,6 mg/kg (máx. 12 mg), 1 dose, com ou sem 2ª no dia seguinte	1–2 dias

[ASBAI] [GINA] [MS]. Dose única pela manhã; sem desmame se < 2 semanas [MS]. Recaída com dexametasona: trocar por prednisolona [GINA].

Reavaliar e decidir

- Reavaliar a cada **20–30 min na 1ª hora**: consciência, FR, FC, SatO2, musculatura acessória, retrações; nenhum parâmetro sozinho decide [ASBAI].
- Pré-escolar: sem resposta em 1 h, SABA necessário a cada 1–2 h ou desconforto depois de 4–6 h do corticoide: pensar em internação [GINA].
- Leve ou moderada que piora ou não responde ao broncodilatador e ao corticoide depois de **2 h** de atendimento: internar [ASBAI].

Exames na crise

Gasometria não é rotina: PFE ou VEF1 < 50%, má evolução ou SatO2 < 92%. PaCO2 normal ou alta numa crise importante é sinal de piora. **Radiografia** só se não responde ou há sinal de complicação (pneumotórax, consolidação). Outros exames raramente ajudam [ASBAI].

Atenção · a taquipneia que não melhora pode ser do salbutamol

Doses altas de SABA causam taquicardia, hipocalemia, arritmia e **acidose láctica**, que aumenta a FR e parece piora da obstrução, levando a ainda mais salbutamol [GINA].

Cai na prova · espaçador não é inferior

pMDI com espaçador é a via preferida na crise leve e moderada; a nebulização fica para quem não coopera ou está muito grave [ASBAI] [GINA]. E corticoide **venoso não é superior ao oral** quando a criança engole [ASBAI].

Conduta · roteiro da 1ª hora

- Monitor, oxímetro; O2 se hipoxêmico.
- Salbutamol com espaçador a cada 20 min, 3 vezes; ipratrópio junto se moderada ou grave.
- Prednisolona oral 1–2 mg/kg (teto pela idade) ainda na 1ª hora.
- Reavaliar a cada 20–30 min; decidir em 1–2 h: alta, observação ou internação.

Capítulo VIII

Não respondeu: internar, UTI ou intubar?

Sulfato de magnésio venoso

Não é rotina. Na crise **grave sem resposta ao tratamento inicial**, acima de 2 anos: dose única de **25–75 mg/kg** em 20 min (máx. 2–2,5 g) [ASBAI]; o GINA usa **40–50 mg/kg, máx. 2 g**, em infusão lenta, depois da 1ª hora [GINA]. Reduz internações. Magnésio nebulizado não tem benefício consistente [ASBAI] [GINA].

Tabela 11 · *Para onde vai a criança*

Destino	Critérios
Internação *(absolutos)*	Piora da dispneia ou do esforço · fadiga (FR e retração diminuindo, assincronia tóraco-abdominal) · **tórax silencioso** ou não consegue falar · O_2 ainda necessário 1 h depois do tratamento inicial · história de asma quase fatal (UTI, intubação)
Internação (relativos)	Crises anteriores com piora rápida · má adesão, uso frequente de SABA · vulnerabilidade social, cuidador sem condições
UTI	Não consegue falar, confusão ou sonolência · hipoxemia apesar do O_2 · hipercapnia moderada a grave. Crise que chega classificada como grave já vai para UTI pediátrica
Intubação	Esforço grave persistente com alteração mental · $PaO_2 < 60$ mmHg com O_2 a 100% ou VNI · hipercapnia progressiva com acidose ou alteração mental · parada

[ASBAI]

Tabela 12 · *O que não fazer na crise*

Antibiótico	**Não**	Não de rotina: a crise costuma ser viral ou ambiental. Tratar se houver infecção bacteriana associada, como pneumonia [ASBAI] [GINA]
Aminofilina, teofilina	**Não**	Risco maior que o benefício [GINA]
Sedativo	**Não**	Deprime o drive respiratório [GINA]
Radiografia de rotina	**Não**	Raramente muda a conduta [ASBAI]
Alto fluxo como rotina	**Não**	Sem benefício demonstrado na crise asmática; VNI pode ser tentada na grave que falha, com vigilância [ASBAI]

Capítulo IX

Quando dar alta e como evitar a próxima?

Pode ir para casa se

- Estável: fora do leito, sem O2 suplementar, come e bebe sem dificuldade [ASBAI] [GINA].
- Pré-escolar: sem recorrência por pelo menos 1–2 h [GINA].
- Escolar: PFE ou VEF1 de 60–80% do previsto ou do melhor pessoal, com melhora clínica [ASBAI].
- Voltar se precisar de SABA de novo em menos de 4 h [GINA].

Prescrição de alta

- **Alívio sob demanda**, anotando o uso diário [ASBAI] [GINA].
- Completar o **corticoide oral**: 3–5 dias na criança, 5–7 no adolescente [ASBAI] [MS].
- **Iniciar CI** se não usava; quem já usava intensifica por 2–4 semanas [ASBAI] [MS].
- Na alta, tratamento conforme as etapas 3 ou 4; **nunca só SABA** [MS].

Tabela 13 · *Retorno depois da crise*

Criança (ASBAI/SBP)	1–2 dias; adolescente, 2–7 dias; e outra consulta em 1–2 meses
Até 5 anos (PCDT, GINA)	1–2 dias (PCDT) · 1–3 dias (GINA)
Geral (PCDT)	2–7 dias; o GINA usa 2–5 dias para crianças

[ASBAI] [MS] [GINA]. Encaminhar ao especialista: ≥ 6 anos, se já houve ≥ 1 crise com corticoide oral ou atendimento de urgência nos últimos 12 meses; ≤ 5 anos, se ≥ 1 crise no período [GINA].

Conduta · educação antes de sair

- Ver a técnica com o dispositivo na mão do paciente; conferir acesso ao remédio.
- **Plano de ação por escrito**: remédios e doses, sinais de piora, onde procurar atendimento.
- Procurar atendimento já se: falta de ar aguda, broncodilatador que não alivia, alívio cada vez mais curto, menor de 1 ano precisando de SABA repetido, mais de 6 jatos nas primeiras 2 h [ASBAI].
- Identificar gatilhos e fatores de risco da crise [ASBAI].

Atenção · "SABA de 4/4 h por 7 dias"

Os fluxogramas do guia brasileiro de 2021 e o AIDPI ainda prescrevem salbutamol em horário fixo na alta [ASBAI] [AIDPI]; o próprio guia, o GINA e o PCDT orientam alívio **sob demanda** com tratamento de manutenção com CI [ASBAI] [GINA] [MS].

Capítulo X

Mapa de decisão e pegadinhas

1 · É asma?	Sintomas variáveis e recorrentes; afastar corpo estranho, aspiração, fibrose cística, malácia, cardiopatia.
2 · Confirmar	≤ 5 anos: recorrência + exclusão + resposta. ≥ 6 anos: espirometria (VEF1 ≥ 12%) ou PFE > 13%.
3 · Controle	4 itens em 4 semanas; gravidade pela etapa necessária; risco futuro à parte.
4 · Manter	≤ 5: SABA + CI diário se > 2×/sem ou crise grave. 6–11: CI sempre que SABA → CI diário → CI-LABA. ≥ 12: budesonida-formoterol sob demanda/MART.
5 · Crise	O2 (SatO2 ≥ 94%), salbutamol 20/20 min ×3 com espaçador, ipratrópio se moderada/grave, prednisolona na 1ª hora.
6 · Escalar	Sem resposta: magnésio IV > 2 anos; internar; UTI se fala prejudicada, sonolência, hipoxemia com O2, hipercapnia.
7 · Alta	Estável, sem O2; corticoide até o fim; iniciar CI; técnica, plano escrito, retorno em 1–2 dias.

Tabela 14 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
Não dá para diagnosticar asma no pré-escolar	Dá: três critérios; se incompletos, "suspeita de asma" e reavaliar
Espirometria normal exclui asma	Costuma ser normal na criança, mesmo com doença ativa
Pouco sibilo, crise leve	Tórax silencioso é obstrução extrema
Nebulizar é mais forte que o espaçador	Espaçador é a via preferida na crise leve e moderada
Corticoide venoso age melhor	Oral é tão eficaz se a criança engole
Toda crise pede RX e antibiótico	Nenhum dos dois é rotina
Asmático não pode tomar ibuprofeno	Pode, salvo asma induzida por anti-inflamatório [SBP-F]
Qualquer CI-LABA serve de alívio	Só com formoterol
Alta só com salbutamol	Sempre com tratamento contendo CI

Capítulo XI

Questões de estudo

1. Menino de 3 anos com 3 episódios de chiado no último ano, cada um com mais de 24 h, um com atendimento de urgência e corticoide oral; tosse noturna entre as crises; melhora com salbutamol; história e exame não sugerem outro diagnóstico. Pelo PCDT:

A Não se diagnostica asma antes dos 6 anos.
B Pode-se diagnosticar asma e iniciar CI diário em dose baixa.
C Basta salbutamol de horário.
D Deve-se fazer espirometria antes de tratar.

2. Escolar de 9 anos com sintomas 1 dia por semana, sem despertares. Pelo PCDT, o tratamento inicial é:

A Salbutamol sob demanda isolado.
B CI em dose baixa sempre que usar o SABA.
C CI-LABA em dose média.
D Montelucaste.

3. Criança de 7 anos em crise: fala frases curtas, musculatura acessória, sibilos difusos, SatO2 91%. A conduta inicial é:

A Aminofilina venosa.
B O2, salbutamol com espaçador a cada 20 min, ipratrópio e prednisolona oral na 1ª hora.
C Radiografia de tórax antes de tratar.
D Amoxicilina e nebulização com soro.

4. Lactente de 18 meses em crise moderada. A dose de prednisolona é:

A 1–2 mg/kg/dia, máximo 20 mg/dia, 3–5 dias.
B 1–2 mg/kg/dia, máximo 60 mg/dia, 10 dias.
C 40–50 mg/dia por 7 dias.
D Não se usa corticoide abaixo de 2 anos.

5. Durante o tratamento de uma crise, a criança fica sonolenta, os sibilos somem e a entrada de ar quase desaparece. Isso indica:

A Melhora: suspender o salbutamol.
B Obstrução extrema e ameaça à vida: UTI e preparar via aérea.
C Efeito colateral do ipratrópio.
D Crise leve.

6. Adolescente de 14 anos com sintomas 1–2 dias por semana. O regime preferencial do PCDT é:

A Salbutamol sob demanda isolado.
B Budesonida-formoterol 200/6 mcg, 1 inalação sob demanda.
C Salmeterol-fluticasona como alívio.
D Corticoide oral em ciclos.

Gabarito comentado

1 · B. Recorrência (≥ 2 episódios > 24 h em 12 meses), sem outra explicação e com resposta ao SABA: asma. Crise com urgência e corticoide indica CI diário [MS].

2 · B. De 6 a 11 anos com sintomas ≤ 1–2 dias/semana: etapa 1, CI em dose baixa sempre que usar SABA. SABA isolado não é recomendado [MS].

3 · B. Crise moderada a grave: O2, SABA repetido, ipratrópio associado e corticoide oral precoce. Aminofilina, RX de rotina e antibiótico não [ASBAI] [GINA].

4 · A. Abaixo de 2 anos, máximo de 20 mg/dia por 3–5 dias [ASBAI] [GINA].

5 · B. Tórax silencioso com sonolência é falência iminente [ASBAI] [GINA].

6 · B. Etapas 1–2 no regime preferencial: CI-formoterol sob demanda. CI-salmeterol não serve de alívio [MS].

Apêndice

Fontes e anotações

- [MS] BRASIL. Ministério da Saúde. *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma*. Portaria Conjunta SAES/SCTIE n.º 43, de 24 mar. 2026.
- [ASBAI] PASTORINO, A. C. et al. Guia prático de atualização ASBAI e SBP para o tratamento da exacerbação de asma na criança e no adolescente. *Arq Asma Alerg Imunol*, v. 5, n. 4, 2021.
- [GINA] GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA. *Global strategy for asthma management and prevention*, 2026.
- [SBP-NT] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Nota técnica n.º 87: corticosteroide inalado associado a beta-agonista de longa duração na terapia de alívio e de manutenção da asma em crianças maiores de 6 anos e adolescentes, ago. 2023.
- [AIDPI] BRASIL. Ministério da Saúde; OPAS. *Manual de quadros de procedimentos: AIDPI Criança*, 2017.
- [SBP-F] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Manejo da febre aguda*, 2021.

Créditos das imagens

- *Treating Kids with Asthma.jpg*: The U.S. Food and Drug Administration, domínio público. Wikimedia Commons.

Anotações